UE D1.1 • SEMESTRE 1 • TD2

POSTURE PROFESSIONNELLE

ET CONTEXTE DE SOIN

Fiche de révision complète — séance du 20 octobre 2026

POURQUOI CE TD ?

Apprendre à identifier une posture professionnelle adaptée à la personne et au contexte, en reliant comportements, communication, sécurité relationnelle et possibilités de réajustement.

Compétence travaillée : établir une relation adaptée à une personne ou à un groupe afin de contribuer à une prise en soin de qualité en mobilisant les compétences psychosociales.

Objectif du TD	Ce qu'il faut savoir faire
Observer	Repérer les éléments verbaux, non verbaux, comportementaux et environnementaux.
Comprendre	Analyser la posture, le contexte de soin et les effets possibles sur la relation.
Agir	Distinguer les comportements adaptés ou inadaptés et proposer un réajustement concret.
Respecter	Faire le lien avec la dignité, l'autonomie, l'intimité, le consentement et les refus.

PRIORITÉS EXPLICITES

Dimensions de la posture, verbal / non-verbal, analyse contextualisée, effets sur la relation, comportements adaptés et inadaptés, ajustements possibles.

PRIORITÉS DÉDUITES DES SIX VIGNETTES

Ponctualité et préparation, langage non infantilisant, vérification de la compréhension, proxémie et symétrie, congruence, intimité et autoévaluation.

Parcours du cours

01 Posture professionnelle	**02** Relation de soin
03 Communication	**04** Langage adapté
05 Feedback	**06** Non-verbal et proxémie
07 Consentement et intimité	**08** Rigueur en stage
09 Cas pratiques 1 et 2	**10** Cas pratiques 3 et 4
11 Cas pratiques 5 et 6	**12** Méthode d'analyse
13 Pièges QCM	**14** Synthèse générale
15 Définitions et mots-clés	

01 Comprendre la posture professionnelle

ESSENTIEL

La posture ne se limite ni au geste technique ni à une apparence : elle associe manière d'être, d'agir, de communiquer et capacité de réajustement.

La **posture professionnelle** n'est pas seulement une attitude corporelle : elle associe le comportement, le langage, l'écoute, la façon de se présenter, les choix réalisés avant et pendant un soin et l'adaptation à la situation. Elle est perceptible par la personne soignée, ses proches et l'équipe. Elle participe à une démarche de **bientraitance**.

Le support du TD décrit une manière d'être, d'agir et de dire soucieuse d'autrui, respectueuse des choix et des refus, attentive à l'écoute active, à la juste distance et au contexte. La relation de soin repose sur cette adaptation à la personne.

Dimension	Dans la pratique
Éthique et relationnelle	Respect de la dignité, des choix, de l'intimité et du consentement ; absence d'infantilisation.
Communication	Mots adaptés, rythme compréhensible, regard, posture corporelle, observation des réactions.
Organisationnelle	Ponctualité, anticipation, connaissance de la situation, préparation du soin et transmission utile.
Réflexive	Reconnaître une maladresse, accueillir un retour, corriger sa pratique et analyser le soin.

À retenir

Une bonne intention ne suffit pas : un geste ou une expression peut avoir un effet négatif même sans volonté de mal faire. L'objectif du TD est d'**analyser sans juger** et de progresser.

02 La relation de soin : place de la personne

ESSENTIEL

Le soin ne consiste pas seulement à traiter une pathologie : il engage la dignité, les besoins, l'autonomie et la qualité du lien avec la personne soignée.

La compétence générique annoncée dans le support consiste à **établir une relation adaptée à une personne ou à un groupe** afin de contribuer à une prise en soin de qualité en mobilisant les compétences psychosociales. La personne ne se réduit pas à une pathologie ou à un acte technique : elle conserve des besoins, une histoire, des émotions, une autonomie et une dignité.

Le TD insiste sur l'importance d'observer ce que le comportement du professionnel fait ressentir : confiance ou défiance, possibilité de poser une question, sentiment d'être considéré, compréhension du soin et disponibilité à participer. Ces effets restent des **hypothèses à vérifier avec la personne**, jamais des conclusions automatiques.

Posture aidante	Posture qui questionne
Se présenter et solliciter la personne.	Entrer directement dans le soin sans établir de contact.
Expliquer avant le geste, laisser répondre.	Multiplier les consignes pendant l'exécution.
Être attentif à une crispation, un silence.	Supposer que tout va bien parce que la personne acquiesce.
Adapter ses mots et sa distance.	Employer le jargon ou un ton infantilisant sans connaître les préférences.

Note de cours

La formatrice rappelle qu'un soignant peut être techniquement compétent tout en donnant une impression d'indisponibilité s'il reste tourné vers son écran pendant l'échange. Le soin relationnel n'est pas une étape accessoire.

03 Verbal, paraverbal et non verbal

ESSENTIEL

Les mots, la manière de les prononcer et le corps transmettent des informations complémentaires, qui peuvent se renforcer ou se contredire.

Canal	Ce qu’il faut regarder	Exemple en situation de soin
Verbal	Choix des mots, jargon, questions ouvertes, façon de s’adresser à la personne.	Remplacer « votre saturation » seule par une explication du contrôle réalisé.
Paraverbal	Débit, ton, intonation, rythme, volume.	Parler vite en préparant le matériel peut empêcher d’assimiler.
Non verbal	Regard, expressions du visage, orientation du corps, hauteur, distance.	Rester debout au pied du lit peut accentuer la distance.
Comportemental	Actions cohérentes avec les paroles, gestes de respect, disponibilité réelle.	Promettre de fermer une porte puis continuer sans le faire crée un décalage.

04 Un langage respectueux et compréhensible

ESSENTIEL

Adapter son langage signifie éviter à la fois un jargon incompris et une familiarité non souhaitée. L'âge ne justifie pas d'infantiliser.

Les termes professionnels servent à communiquer entre soignants, mais ne sont pas toujours compris par les patients. À l'inverse, des mots familiers comme « gambettes » peuvent sembler **infantilisants**. Le bon registre n'est ni systématiquement technique ni systématiquement familier : il dépend de la personne, de la situation et de ses préférences.

Dans l'exemple de Monsieur B., 78 ans, le « oui, oui » après une suite d'injonctions n'établit ni la compréhension, ni le confort, ni le choix. La formatrice invite à **poser une question à la fois**, laisser le temps de répondre, puis adapter le soin.

Application

Au lieu de « On lève les gambettes, on va faire la petite toilette », préférer : « Bonjour Monsieur B., comment vous sentez-vous ? Je vous propose de préparer votre toilette. Souhaitez-vous commencer maintenant ? Comment préférez-vous procéder ? »

05 Feedback et compréhension du message

ESSENTIEL

Un « oui » ne suffit pas à prouver la compréhension. Le retour d'information vérifie ce que la personne a compris, sans la mettre en difficulté.

Le **feedback** permet de vérifier que le message reçu correspond au message donné. Un « oui » peut traduire l'accord, la politesse, la gêne, le manque d'envie de questionner ou une compréhension réelle : il est impossible de le savoir sans échange. On peut inviter à reformuler, demander les questions ou proposer une nouvelle explication, sans mettre la personne en échec.

À retenir

Le consentement et la compréhension se recherchent activement : **expliquer → laisser le temps → vérifier → demander l'accord**. Le degré de détail souhaité par chaque personne peut varier.

06 Regard, proxémie et symétrie

ESSENTIEL

La proxémie concerne la distance ; la symétrie relationnelle renvoie ici au positionnement et à la hauteur. Les deux sont à adapter au contexte.

La **symétrie relationnelle** désigne ici le fait de rechercher une position de communication moins surplombante, par exemple se mettre à hauteur de la personne au lit quand le contexte le permet. La **proxémie** concerne la distance physique : trop loin, la relation peut paraître distante ; trop près, le soignant peut envahir l’espace intime.

Situation observée	Effet possible	Réajustement
Soignant debout au pied du lit	Distance, rapport asymétrique	Se placer face à la personne et à hauteur adaptée, avec son accord.
Regard absorbé par l’ordinateur	Impression de ne pas être entendu	Débuter par un vrai temps de contact, puis expliquer l’usage de l’écran.
Explication rapide en préparant le matériel	Information peu assimilée	Présenter le soin avant, puis vérifier l’accord et préparer le geste.
Visage de la personne qui se ferme	Inquiétude ou malaise possible	Nommer prudemment ce qu’on observe et laisser la personne répondre.

Précision de la formatrice

Se mettre à hauteur ne signifie pas « s’asseoir systématiquement ». Il faut tenir compte du soin, du temps d’explication et de l’accord de la personne. La symétrie (hauteur) et la proxémie (distance) sont deux éléments différents, mais complémentaires.

07 Consentement, autonomie, intimité

ESSENTIEL

Un soin répété reste un soin à expliquer. Protéger la pudeur et prendre en compte l'accord ou le refus de la personne font partie de la posture.

Avant un soin, la personne doit être informée avec des mots adaptés et pouvoir exprimer un choix ou un refus. Un soin habituel ne dispense pas de rechercher son accord. Le **consentement** ne peut pas être présumé à partir de la répétition d'une routine ou d'un « oui » prononcé sans réel échange.

L'**intimité** recouvre notamment l'exposition du corps et la maîtrise de l'espace personnel. Pendant une toilette, laisser la porte ouverte alors que la personne est découverte constitue un défaut de posture. Même si l'équipe effectue ce geste tous les jours, la nudité peut rester sensible pour la personne.

Avant	Pendant	Après
Frapper, attendre, se présenter ; fermer la porte selon le soin et l'accord.	Préserver l'exposition du corps ; rester attentif aux réactions ; respecter une demande formulée.	S'assurer du vécu du soin, répondre aux questions et analyser d'éventuelles maladresses.
Expliquer ce qui est prévu ; demander si la personne est prête et comment elle souhaite participer.	Faire correspondre les paroles aux actes ; réajuster si quelque chose inquiète.	Réévaluer sa pratique, si nécessaire avec le tuteur.

À retenir

La **congruence**, terme repris par l'intervenante, est la cohérence entre ce que le professionnel dit, pense et fait. « Je ferme la porte » suivi d'aucune action est un exemple de non-congruence.

08 Rigueur, ponctualité et rôle de l’étudiant

ESSENTIEL

Un retard doit être anticipé et signalé, mais la précipitation ne doit pas dégrader les soins relationnels. La portée du retard sur le service dépend du contexte.

La ponctualité fait partie de la posture professionnelle. Dans la première vignette, l’étudiant arrive en retard à plusieurs reprises, puis entre précipitamment sans se présenter. La formatrice distingue le constat objectif (retard répété) des intentions supposées. Le risque pédagogique mis en avant est la précipitation, qui peut dégrader l’attention aux informations, aux soins techniques et à la relation.

L’enseignante propose d’**anticiper les déplacements**, de prévenir honnêtement l’équipe lorsqu’un imprévu survient et de conserver les règles relationnelles même sous pression. Elle souligne qu’un retard peut perturber le travail du tuteur ; la portée exacte sur l’organisation du service a fait l’objet d’une divergence de points de vue dans le groupe et ne doit pas être présentée comme absolue.

Note de cours : nuance importante

Être étudiant ne signifie pas « ne pas compter » : les apprentissages et soins peuvent être planifiés avec le tuteur. Pour autant, l’organisation générale du service n’est pas la responsabilité autonome d’un étudiant ; la portée d’un retard dépend du contexte.

09

Situations de soin — cas 1 et 2

ESSENTIEL

Pour chaque vignette, distinguer les faits observables, les effets possibles et les réajustements professionnels.

Situation 1 — Retards et absence de présentation

Faits : arrivée à 7 h 12 pour 7 h, retards répétés, puis entrée dans la chambre de Mme L. sans se présenter pour « rattraper » le retard.

Ce qui pose question : rigueur, accueil, préparation et attention. **Effets possibles :** mauvaise première impression, perte de confiance, précipitation, oubli d’éléments utiles.

Ajustement concret

Faire autrement : anticiper, informer le tuteur en cas de retard, recueillir les informations nécessaires, frapper et se présenter, ne pas sacrifier la relation au souci de vitesse.

Situation 2 — Toilette et langage infantilisant

Faits : à Monsieur B., 78 ans, on adresse des formulations familières et directives ; il répond « oui, oui ».

Ce qui pose question : langage, succession de consignes, compréhension, consentement et éventuelle infantilisation. **Effets possibles :** gêne, retrait, manque de considération.

Ajustement concret

Faire autrement : langage courant respectueux, questions ouvertes, une consigne à la fois, participation de la personne et vérification de son choix.

10 Situations de soin — cas 3 et 4

ESSENTIEL

Pour chaque vignette, distinguer les faits observables, les effets possibles et les réajustements professionnels.

Situation 3 — Ordinateur, débit et distance

Faits : le soignant regarde son ordinateur, reste debout au pied du lit et explique le soin rapidement tout en préparant le matériel ; Mme R. paraît tendue.

Ce qui pose question : regard, position du corps, rythme, temps de compréhension. **Effets possibles :** inquiétude, distance ressentie, accord insuffisamment éclairé.

Ajustement concret

Faire autrement : établir un contact, se mettre à hauteur adaptée, expliquer avant le soin, observer les réactions, proposer une pause et demander ce qui préoccupe.

Situation 4 — Porte ouverte pendant une toilette

Faits : la patiente déjà découverte demande de fermer la porte ; le soignant dit qu'il va le faire mais poursuit sa préparation.

Ce qui pose question : intimité, dignité, consentement et non-congruence. **Effets possibles :** humiliation, sentiment de ne pas être écoutée, perte de confiance.

Ajustement concret

Faire autrement : répondre à la demande immédiatement, protéger l'exposition du corps, expliquer le soin, utiliser les repères de présence selon l'organisation du service.

11 Situations de soin — cas 5 et 6

ESSENTIEL

Pour chaque vignette, distinguer les faits observables, les effets possibles et les réajustements professionnels.

Situation 5 — Jargon et « oui, d’accord »

Faits : l’étudiant annonce une vérification de la saturation, de la fréquence respiratoire et de la pression artérielle, puis poursuit sans vérifier la compréhension.

Ce qui pose question : jargon non expliqué, faible place laissée à la personne, feedback absent. **Effets possibles :** questions non exprimées, incompréhension.

Ajustement concret

Faire autrement : expliquer chaque mesure en termes accessibles, en donner le sens, inviter aux questions, vérifier la compréhension, demander l’accord.

Situation 6 — Mauvaise nouvelle et échange entre collègues

Faits : deux soignants entrent en plaisantant auprès de Mme S., qui vient d’apprendre une mauvaise nouvelle médicale ; elle reste silencieuse.

Ce qui pose question : défaut d’attention au contexte émotionnel, indisponibilité. **Effets possibles :** retrait, perte de confiance, moindre envie de se confier.

Ajustement concret

Faire autrement : interrompre la plaisanterie avant d’entrer, adapter l’attitude, permettre un échange calme et confidentiel, proposer une écoute sans l’imposer.

12 Méthode d’analyse d’une situation

ESSENTIEL

Une réponse structurée distingue les faits, les conséquences possibles sur la relation et un ajustement réalisable.

Étape	Question à se poser	Ce que l’on écrit dans une copie
1. Observer	Qu’est-ce qui est objectivement décrit ?	Faits sans diagnostic psychologique ni intention prêtée.
2. Comprendre	Quelle dimension de la posture est engagée ?	Communication, consentement, intimité, rigueur, contexte émotionnel…
3. Relier	Quel impact est possible pour la personne ?	Hypothèses nuancées : « peut », « risque de », « pourrait ressentir ».
4. Agir	Quel ajustement observable peut être proposé ?	Frapper, expliquer, regarder, ralentir, demander, reformuler, protéger.
5. Évaluer	Comment savoir si l’ajustement convient ?	Retour de la personne, observation, réévaluation avec le tuteur.

Cette démarche permet d’éviter la réponse trop abstraite (« être gentil ») : on passe d’un constat à une action professionnelle vérifiable. Le TD valorise aussi l’**autoévaluation** : remarquer une maladresse, pouvoir s’excuser et modifier immédiatement son attitude, puis prendre du recul après le soin.

À retenir

L’autoanalyse n’est pas de l’autocritique stérile. Elle sert à identifier un écart entre l’intention et la pratique, à solliciter un retour et à préparer un meilleur soin la fois suivante.

13 Pièges QCM / confusions à éviter

ESSENTIEL

Ne pas transformer des signes observés en diagnostics certains ; distinguer bonne intention et posture effectivement adaptée.

• **Être ponctuel ≠ avoir automatiquement une bonne posture** : frapper et respecter l'intimité restent indispensables.

• **« Oui, oui » ≠ compréhension démontrée** : rechercher un retour d'information et une expression libre de la personne.

• **Parler avant un soin ≠ parler pendant tout le soin** : l'information doit pouvoir être assimilée avant de commencer.

• **Symétrie ≠ proxémie** : la première renvoie ici à la hauteur relationnelle, la seconde à la distance.

• **Langage professionnel ≠ jargon systématique** : ajuster le vocabulaire sans infantiliser.

• **Non-congruence ≠ mensonge volontaire** : un écart entre parole et acte peut survenir sans intention de tromper ; il faut néanmoins le corriger.

• **Routine ≠ consentement acquis** : chaque soin reste une rencontre avec la personne.

• **Silence ou tension ≠ preuve de la cause** : observer et questionner, sans attribuer un état mental certain.

• **Présence du tuteur ≠ absence de responsabilité professionnelle de l'étudiant** : l'étudiant doit agir avec rigueur dans les limites de ses compétences.

14 Synthèse générale — L’essentiel du cours

ESSENTIEL

Repères à relire pour retrouver l’ensemble des notions avant les entraînements.

1. **Observer sans juger.** Décrire des faits et des comportements, sans attribuer d’intentions ou de diagnostics non établis.

2. **Expliquer et vérifier.** Adapter ses mots, laisser du temps, chercher le feedback et l’accord pour le soin.

3. **Protéger la personne.** Respecter intimité, dignité, autonomie, pudeur, choix et refus.

4. **Mobiliser tout le corps.** Regard, ton, débit, position, proximité et hauteur envoient des messages.

5. **Être cohérent.** Aligner paroles et actes (congruence), reconnaître les maladresses et corriger sa conduite.

6. **S’organiser.** Anticiper, accueillir, recueillir les éléments utiles et éviter de traiter la précipitation comme une excuse relationnelle.

7. **Recontextualiser.** Les six cas étudiés illustrent des problèmes différents mais une même méthode : faits → effets possibles → réajustement.

FIL CONDUCTEUR DE LA POSTURE

Observer → écouter → expliquer → vérifier → respecter → réajuster. Le soin relationnel est une dimension essentielle de la qualité de prise en soin.

15 Définitions et mots-clés

ESSENTIEL

Lexique de révision : termes importants du TD et distinctions à connaître.

Posture professionnelle	Manière d’être, d’agir, de communiquer et de s’ajuster dans une situation de soin.
Bientraitance	Approche visant une relation respectueuse des besoins, choix, dignité et singularité de la personne.
Relation de soin	Lien professionnel construit pendant l’accompagnement et les interventions de soin.
Soin relationnel	Dimension du soin qui passe par la présence, l’écoute, l’explication et la qualité de l’interaction.
Compétences psychosociales (CPS)	Capacités mobilisées pour interagir, communiquer, comprendre les émotions et s’adapter aux relations.
Communication verbale	Message porté par les mots et les formulations.
Communication paraverbale	Manière de prononcer un message : ton, rythme, volume, débit et intonation.
Communication non verbale	Informations communiquées notamment par le regard, l’expression du visage, le corps et la gestuelle.
Feedback	Retour permettant de vérifier comment un message a été reçu ou compris.
Écoute active	Écoute attentive qui laisse la personne s’exprimer et cherche à comprendre son point de vue.
Congruence	Cohérence entre propos, intention, attitude et actions du professionnel.
Non-congruence	Décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fait.
Proxémie	Distance physique entre des personnes dans une interaction.

16 Définitions et mots-clés — suite

ESSENTIEL

Lexique de révision : termes importants du TD et distinctions à connaître.

Symétrie relationnelle	Recherche d’une position moins surplombante et d’un échange où chacun peut s’exprimer.
Distance relationnelle juste	Proximité adaptée au contexte, respectant l’espace personnel et la relation de soin.
Consentement	Expression de l’accord pour un soin après une information adaptée et la possibilité de choisir.
Autonomie	Possibilité pour la personne de participer aux décisions et aux activités qui la concernent selon ses capacités.
Dignité	Valeur et respect dus à chaque personne indépendamment de son état de santé.
Intimité	Espace privé et personnel, notamment du corps et de la vie personnelle, à protéger pendant les soins.
Infantilisation	Façon de traiter une personne comme un enfant de manière inappropriée.
Jargon professionnel	Vocabulaire technique de métier potentiellement difficile à comprendre pour un non-professionnel.
Vulnérabilité	Situation où une personne peut être plus exposée à une atteinte à son autonomie, son confort ou sa sécurité.
Autoévaluation	Analyse de sa propre pratique pour identifier les points forts, les difficultés et les améliorations.
Réajustement	Modification d’une attitude ou d’un geste en fonction d’un constat et du retour de la personne.
Contexte de soin	Ensemble des circonstances cliniques, relationnelles, environnementales et émotionnelles d’un soin.
Tuteur de stage	Professionnel qui accompagne et supervise l’étudiant dans les apprentissages pratiques.